Дата: 04.10.2026
Полис: 6452620897052978

Выписной эпикриз универсальный (канцер-регистр)

Дата и время: 04-10-2026 18:05:00

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы";

Данные о пациенте и времени его пребывания в больнице

Отделение: Диагностическое отделение № 2;

Условия проведения лечения: круглосуточный стационар; Источник финансирования: ОМС;

Дата поступления в стационар: 03-10-2026 18:13;

Пациент находился

С: 03-10-2026 19:52; По: 04-10-2026 18:01; Диагностическое отделение № 2;

Дата выписки из стационара: 04-10-2026 18:01;
Кол-во койко-дней: дней:1;
Исход госпитализации: улучшение;

Диагноз при поступлении

Основной диагноз

Код по МКБ 10: K83.9 Болезнь желчевыводящих путей неуточненная; Развернутый клинический диагноз: Болезнь желчевыводящих путей неуточненная.;

Диагноз при выписке

Основной диагноз

Код по МКБ 10: C18.7 Злокачественное новообразование сигмовидной кишки;

Развернутый клинический диагноз Рак сигмовидной кишки T3N1M1 (HEP). IV стадия.
ЧЧХС от 28.08.2026. Функционирующие дренажи желчных протоков.

Сторона поражения: неприменимо;

Опухоль -TNM раковое стадирование Стадия TNM: неприменимо; Клиническая группа: II;

Жалобы

на слабость , желтушность склер и кожных покровов.;

Анамнез заболевания

Дата начала заболевания: 02.10.2026 18:32. Доставлен в стационар: по направлению поликлиники. Со слов: вышеуказанные жалобы в течение суток. Со слов после промывания ЧЧХС перестала функционировать. Врачом поликлиники направлена в ССК ГКБ № 15.. Данное заболевание: впервые. Начало заболевания: постепенное. К врачу: обращался.
Анамнез заболевания пациента с ОНМК
Невозможно оценить: нет.

анамнез жизни;

Хронические заболевания: Рак сигмовидной кишки T3N1M1 (HEP). IV стадия
II клиническая группа
ЧЧХС 28.08.2026 в ФГБУ им. Герцена. Перенесенные заболевания: Вирусные гепатиты, ВИЧ, туберкулез, сифилис у себя отрицает. Перенесенные операции: ЧЧХС 28.08.2026 в ФГБУ им. Герцена. Постоянно принимает: отрицает. Реакция на: нет. Выезд за пределы города (в том числе за пределы РФ): нет. Контакт с инфекционными больными или носителями: нет. Сведения о контактах с животными, грызунами, птицами, сырьем животного происхождения: нет. Сведения об укусах насекомых, животных: нет. Купание в открытых водоемах: нет. Употребление воды из открытых источников, некипяченой воды: нет. Питание в местах общественного питания: нет. Лечение и обследование в МО: нет. Медицинские манипуляции (инъекции, гинекологические, стоматологические, хирургические и другие вмешательства): нет. Прием антибиотиков в течение последних 6 месяцев: нет. В настоящее время: неработающий.

Состояние при поступлении

Объективный статус

Рост/длина тела: 165 см; Масса тела: 55 кг; ИМТ: 20,2 кг/кв.м; Площадь поверхности тела: 1,59 кв.м;

Общие сведения
Общее состояние: удовлетворительное. Сознание: ясное. Питание: удовлетворительное.
Состояние кожных покровов, видимых слизистых, лимфатических узлов
Цвет кожных покровов: желтушный. Влажность кожи: нормальная. Тургор: сохранен. Наличие отеков: отсутствуют.
Состояние органов дыхания
Тип дыхания: самостоятельное. ЧДД: 17 /мин; Ритм дыхания: регулярный. Дыхание: нормальное. Дыхание самостоятельное: естественным путем. Описание дыхания: .
Участие грудной клетки в дыхании: равномерное. SPO2: 97 %; Характер дыхания: везикулярное (нормальное). Хрипы: нет.
Состояние сердечно-сосудистой системы
Систолическое давление: 125 мм.рт.ст.; Диастолическое давление: 76 мм.рт.ст.; ЧСС: 73 /мин; Пульс: 73 /мин; Дефицит пульса: 0 1/мин;
Состояние органов желудочно-кишечного тракта
Цвет языка: бледно-розовый. Размер живота: не увеличен. Симметричность живота: симметричный. Форма живота: распластанная. Вздутие: нет. Участие живота в акте дыхания: участвует. Живот при пальпации: мягкий. Болезненность живота при пальпации: нет. Симптомы раздражения брюшины: отрицательные.
Состояние мочеполовой системы
Мочеиспускание с начала заболевания: было. Мочеиспускание: не нарушено. Характер мочеиспускания: безболезненное. Симптомы поколачивания: отрицательный с двух сторон.
Состояние органов зрения
Склеры: иктеричные.

местный, локальный статус;

Локальный статус: в правом подреберье ЧЧХС , по последней следы темной желчи. В левом подреберье функционирующий дренаж, по последнему около 50 мл светлой жидкости.;

Инструментальные исследования

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и забрюшинного пространства 03-10-2026 18:55;

ПЕЧНЬ. Контуры ровные, четкие. Размеры печени в пределах физиологической нормы. Структура печени однородная. Эхогенность средняя. Сосудистый рисунок обычный. Воротная вена не расширена. Дополнительные образования определяются в виде округлых, повышенной эхогенности образований различного размера с нечеткими и не ровными контурами.
ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ. Размеры не увеличены. Стенка желчного пузыря не утолщена, однослойная. Просвет анэхогенный, однородный.
ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ. Внутрипеченочные не расширены, внепеченочные экранированы. В проекции ворот печени, паренхимы печени, определяются линейные гиперэхогенные структуры.
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА экранирована, не визуализируется.
СЕЛЕЗЕНКА. Контур ровный, размеры не увеличены, структура однородная.
КИШЕЧНИК тонкий и толстый содержит большое количество газа что осложняет общую визуализацию. В визуализируемых областях перистальтика прослеживается.

СВОБОДНАЯ ЖИДКОСТЬ в брюшной полости не определяется.
ПОЧКИ. Расположены типично. Контуры ровные, четкие. Размеры в пределах физиологической нормы. Чашечно-лоханочная система не расширена.
Забрюшинное пространство без видимой патологии.

Заключение: УЗ признаки метастазов в печени, дренированных желчевыводящих путей.

Рентгенография органов грудной клетки 03-10-2026 19:12;

На Rg-граммах органов грудной клетки в двух проекциях - легочные поля одинаково прозрачны в симметричных отделах с обеих сторон, без свежих очаговых и инфильтративных теней. Легочный рисунок прослеживается в видимых отделах, структурен. Корни легких структурны, не расширены. Видимые синусы свободны. Контуры диафрагмы четкие, ровные. Тень сердца не расширена. Аорта не изменена.

Заключение
Очаговых и инфильтративных изменений не выявлено.

Рентгенография брюшной полости 03-10-2026 19:13;

На рг-ме органов брюшной полости в прямой проекции в вертикальном положении - свободного газа в брюшной полости не определяется. По ходу толстой кишки газ и содержимое. В мезогастрии определяются единичные пневматизированные петли тонкой кишки. Тень дренажных трубок справа на уровне Th2.

Заключение
На момент проведения исследования признаков ОКН/перфорации полого органа - нет.

Магнитно-резонансная холангиопанкреатография 04-10-2026 16:47;

Внутрипечёночные желчные протоки в единичном порядке умеренно расширены в правой доле печени сегментарные до 4.8мм в 6 и 7 сегменте, остальные до 2.0мм, наличие дренажа в 8 сегменте проксимальный конец которого в просветите сегментарного протока;
в левой доле печени сегментарные до 3.3мм,с наличием дренажа в 3 сегменте печени проксимальный конец которого в просветите сегментарного протока;
Многочисленные объемные образования печени разного калибра во обеих долях печени размером от 20х15мм, до 96х95мм в области ворот печени; на уровне конфлюенса ППП, ЛПП и ОПП не прослеживаются.
На остальном уровне ОПП до2.6мм ; холедох диаметром до 4.5мм впадает в 12-перстную кишку.
Желчный пузырь грушевидной формы, размером до 57х36мм, стенка не утолщена до 3,5мм, содержимое однородное.
Пузырный проток имеет обычное впадение , диаметром до 3.0мм.
Проток поджелудочной железы прослеживается на всем протяжении, диаметром до 1.7мм в головной части (норма до 3,1мм), до 1.5мм в теле , до 1.5мм хвостовой части (норма до 2.5мм).
Умеренное количество свободной жидкости в брюшной полости.
Печень резко увеличена в размерах: правой доли до 243мм (норма 150см), левой доли до 87мм (норма до 50см).

Заключение
Мр-данные компрессии протоков на уровне конфлюенса печеночных желчных протоков объемным образованием, наличие дренажей в правой и левой долях печени в сегментарных протоках.
Умеренно выраженная дилатация отдельных внутрипеченочных желчных протоков.
Свободная жидкость в брюшной полости.
Объемные образования печени (более вероятно вторичный характер). Гепатомегалия.

Лабораторные исследования

Клинический анализ крови (5 Diff(венозная кровь)); Дата и время исследования: 03-10-2026 18:28;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание
Гемоглобин общий	101	г/л	120 - 140	

Количество эритроцитов	3,80	10^12/л	3.9 - 4.7	
Гематокрит	0,311	л/л	0.36 - 0.42	
Средний объем эритроцита	81,7	фл	80 - 100	
Среднее содержание гемоглобина в эритроците	26,4	пг	27 - 31	
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците	324	г/л	320 - 380	
Ширина распределения эритроцитов по объему	14,8	%	11.5 - 14.5	
Количество тромбоцитов	589	10^9/л	150 - 450	
Средний объем тромбоцитов в крови	8,1	фл	7 - 10	
Общий объем тромбоцитов в крови (тромбокрит, PCT)	0,480	%	0.15 - 0.4	
Ширина распределения тромбоцитов по объему	9,3	фл	9 - 17	
Количество лейкоцитов	18,43	10^9/л	4 - 9	
Относительное количество нейтрофилов	80,8	%	50 - 72	
Относительное количество лимфоцитов	10,1	%	19 - 37	
Относительное количество моноцитов	7,6	%	3 - 12	
Относительное количество эозинофилов	1,1	%	1 - 5	
Относительное количество базофилов	0,4	%	0 - 1.5	
Абсолютное количество нейтрофилов	14,90	10^9/л	2 - 7.5	
Абсолютное количество лимфоцитов	1,86	10^9/л	1.2 - 3	
Абсолютное количество моноцитов	1,40	10^9/л	0.3 - 1.1	
Абсолютное количество эозинофилов	0,20	10^9/л	0 - 0.5	
Абсолютное количество базофилов	0,07	10^9/л	0 - 0.1	

Общий белок; Дата и время исследования: 03-10-2026 18:52;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание
Общий белок	80,10	г/л	66 - 83	

АЛТ; Дата и время исследования: 03-10-2026 18:52;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание
АЛТ	19,8	МЕ/л	0 - 35	

АСТ; Дата и время исследования: 03-10-2026 18:52;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание
АСТ	103,6	МЕ/л	<35	

Щелочная фосфатаза; Дата и время исследования: 03-10-2026 18:52;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание

Щелочная фосфатаза	358,7	МЕ/л	30 - 120	

Альфа-амилаза; Дата и время исследования: 03-10-2026 18:52;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание
Альфа-амилаза	47,80	МЕ/л	28 - 100	

Глюкоза; Дата и время исследования: 03-10-2026 18:52;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание
Глюкоза	7,56	мМоль/л	4.1 - 5.9	

Мочевина; Дата и время исследования: 03-10-2026 18:52;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание
Мочевина	4,70	мМоль/л	2.8 - 7.2	

Креатинин; Дата и время исследования: 03-10-2026 18:52;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание
Креатинин	61,9	мкмоль/л	58 - 96	

Билирубин общий; Дата и время исследования: 03-10-2026 18:52;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание
Билирубин общий	167,40	мкмоль/л	5 - 21	

Билирубин прямой (конъюгированный) моноглюкоронид и диглюкоронид; Дата и время исследования: 03-10-2026 18:52;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание
Билирубин прямой (конъюгированный) моноглюкоронид и диглюкоронид	94,40	мкмоль/л	<3,4	

СРБ; Дата и время исследования: 03-10-2026 18:52;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание
Определение белков острой фазы С-реактивный белок	50,20	мг/л	<5	

Клинический анализ крови (5 Diff + микроскопия при патологии (венозная кровь)); Дата и время исследования: 04-10-2026 09:19;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание

Гемоглобин общий	98	г/л	120 - 140	
Количество эритроцитов	3,75	10^12/л	3.9 - 4.7	
Гематокрит	0,300	л/л	0.36 - 0.42	
Средний объем эритроцита	80,0	фл	80 - 100	
Среднее содержание гемоглобина в эритроците	26,2	пг	27 - 31	
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците	328	г/л	320 - 380	
Ширина распределения эритроцитов по объему	12,9	%	11.5 - 14.5	
Количество тромбоцитов	545	10^9/л	150 - 450	
Средний объем тромбоцитов в крови	8,6	фл	7 - 10	
Общий объем тромбоцитов в крови (тромбокрит, PCT)	0,467	%	0.15 - 0.4	
Ширина распределения тромбоцитов по объему	10,5	фл	9 - 17	
Количество лейкоцитов	15,48	10^9/л	4 - 9	
Относительное количество гранулоцитов	89,0	%	48 - 80	
Относительное количество лимфоцитов	4,7	%	19 - 37	
Относительное количество моноцитов	6,3	%	3 - 12	
Абсолютное количество гранулоцитов	13,77	10^9/л	2 - 6.5	
Абсолютное количество лимфоцитов	0,73	10^9/л	1.2 - 3	
Абсолютное количество моноцитов	0,98	10^9/л	0.3 - 1.1	

Билирубин общий; Дата и время исследования: 04-10-2026 09:31;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание
Билирубин общий	172,20	мкмоль/л	5 - 21	

Билирубин прямой (конъюгированный) моноглюкоронид и диглюкоронид; Дата и время исследования: 04-10-2026 09:31;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание
Билирубин прямой (конъюгированный) моноглюкоронид и диглюкоронид	98,60	мкмоль/л	<3,4	

СРБ; Дата и время исследования: 04-10-2026 09:31;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание
Определение белков острой фазы С-реактивный белок	53,28	мг/л	<5	

Клинический анализ крови (5 Diff + микроскопия при патологии (венозная кровь)); Дата и время исследования: 04-10-2026 16:23;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание
Гемоглобин общий	101	г/л	120 - 140	

Количество эритроцитов	3,82	10^12/л	3.9 - 4.7	
Гематокрит	0,315	л/л	0.36 - 0.42	
Средний объем эритроцита	82,7	фл	80 - 100	
Среднее содержание гемоглобина в эритроците	26,4	пг	27 - 31	
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците	319	г/л	320 - 380	
Ширина распределения эритроцитов по объему	14,8	%	11.5 - 14.5	
Количество тромбоцитов	524	10^9/л	150 - 450	
Средний объем тромбоцитов в крови	8,9	фл	7 - 10	
Общий объем тромбоцитов в крови (тромбокрит, PCT)	0,467	%	0.15 - 0.4	
Ширина распределения тромбоцитов по объему	10,7	фл	9 - 17	
Количество лейкоцитов	14,75	10^9/л	4 - 9	
Относительное количество нейтрофилов	81,1	%	50 - 72	
Относительное количество лимфоцитов	9,7	%	19 - 37	
Относительное количество моноцитов	7,4	%	3 - 12	
Относительное количество эозинофилов	1,5	%	1 - 5	
Относительное количество базофилов	0,3	%	0 - 1.5	
Абсолютное количество нейтрофилов	11,97	10^9/л	2 - 7.5	
Абсолютное количество лимфоцитов	1,43	10^9/л	1.2 - 3	
Абсолютное количество моноцитов	1,09	10^9/л	0.3 - 1.1	
Абсолютное количество эозинофилов	0,22	10^9/л	0 - 0.5	
Абсолютное количество базофилов	0,04	10^9/л	0 - 0.1	

Билирубин общий; Дата и время исследования: 04-10-2026 16:40;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание
Билирубин общий	156,30	мкмоль/л	5 - 21	

Билирубин прямой (конъюгированный) моноглюкоронид и диглюкоронид; Дата и время исследования: 04-10-2026 16:40;

Наименование теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения	Примечание
Билирубин прямой (конъюгированный) моноглюкоронид и диглюкоронид	90,10	мкмоль/л	<3,4	

Консультации специалистов

Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 04-10-2026 17:36:11;

Заключение У пациентки рак сигмовидной кишки T3N1M1 (HEP). IV стадия. ЧЧХС от 28.08.2026. Миграция дренажа? (C18.7)Метод подтверждения диагноза: морфологический; Клиническая группа: II. По МР-холангиографии от 4.10.26: Мр-данные компрессии протоков на уровне конфлюенса печеночных желчных протоков объемным образованием, наличие дренажей в правой и левой долях печени в сегментарных протоках. Умеренно выраженная дилатация отдельных внутрипеченочных желчных протоков.

Учитывая умеренное расширение протоков и наличие функционирующих дренажей желчных протоков печени, эндоваскулярное вмешательство в объеме дренирования желчных протоков печени на момент осмотра не показано.

Консилиумы

Онкологический консилиум: Нет
Состав консилиума:

Операции

Медикаментозное лечение

Натрия хлорид 400.0 мл
Папаверин 40.0 мг
Дата начала: 03-10-2026; Дата окончания: 03-10-2026; Внутривенно капельно, однократно, 21:43 ч., 1 день,;

Калия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Натрия хлорид 400.0 мл
Дата начала: 03-10-2026; Дата окончания: 03-10-2026; Внутривенно капельно, однократно, 21:44 ч., 1 день,;

Натрия хлорид 800.0 мл
Дата начала: 04-10-2026; Дата окончания: 04-10-2026; Внутривенно капельно, однократно, 13:17 ч., 1 день,;

Диета

Описание лечения

Состояние при выписке

Объективный статус

Общие сведения
Общее состояние: удовлетворительное. Сознание: ясное.
Состояние кожных покровов, видимых слизистых, лимфатических узлов
Цвет кожных покровов: субиктеричный. Влажность кожи: нормальная. Тургор: сохранен. Цианоз: отсутствует.
Состояние костно-мышечной системы
Подробно
Повреждения: нет.
Состояние органов дыхания
Тип дыхания: самостоятельное. ЧДД: 15 /мин; Ритм дыхания: регулярный. Дыхание: нормальное. Дыхание самостоятельное: естественным путем. Описание дыхания: .
Характер дыхания: везикулярное (нормальное).
Состояние сердечно-сосудистой системы
Систолическое давление: 130 мм.рт.ст.; Диастолическое давление: 90 мм.рт.ст.; Пульс: 80 /мин; Наполнение пульса: умеренного наполнения.
Состояние органов желудочно-кишечного тракта
Цвет языка: розового цвета. Налет на языке: отсутствует. Влажность языка: влажный. Живот при пальпации: мягкий. Напряжение живота: нет. Болезненность живота при пальпации: нет. Симптомы раздражения брюшины: отрицательные. Перкуторный звук: ясный. Локализация звука: над всей поверхностью живота. Аускультация: перистальтика выслушивается, "шум плеска" отрицательный.
Состояние мочеполовой системы
Мочеиспускание: свободно. Цвет мочи: соломенно-желтый.
Состояние органов зрения
Зрачки: нормальные. Склеры: краевая субиктеричность.

местный, локальный статус;

Локальный статус: Дренажи желчных протоков функционируют, поступает желчь тёмно-коричневого цвета в достаточном количестве, за время наблюдения дебит 200 мл.
Повязки чистые, сухие.

Исход и результат госпитализации

Результат госпитализации: выписан из стационара;

Проведённое лечение первичной опухоли: симптоматическое;

Заключение

У пациентки Рак сигмовидной кишки T3N1M1 (HEP), IV стадия. Метастатическое поражение печени (разобщение на уровне конфлюенса желчных протоков).
ЧЧХС от 28.08.2026. Функционирующие дренажи желчных протоков (правый и левый долевой проток).
Данных за дислокацию дренажей, холангит, острый панкреатит нет. Пациентка консультирована дежурным врачом рентген-эндоваскулярной диагностики: учитывая умеренное расширение протоков и наличие функционирующих дренажей желчных протоков печени, эндоваскулярное вмешательство в объеме дренирования желчных протоков печени на момент осмотра не показано. Показаний к экстренной операции нет. За время наблюдения в диагностическом отделении дренажи функционировали, поступает желчь. Дренажи промывались, выполнялись перевязки.
Проводилась консервативная дезинтоксикационная терапия - с положительным эффектом. В лабораторных анализах снижение уровня билирубина. В дальнейшем стационарном лечении не нуждается. Выписывается в удовлетворительном состоянии. Рекомендации даны.

Рекомендации

Лекарственная терапия:

Ежегодное прохождение диспансеризации (профилактического медицинского осмотра).

Наблюдение у онколога амбулаторного звена.

Ежедневные перевязки области стояния дренажей. Ежедневное промывание дренажей физиологическим раствором натрия хлорида 0.9% х 2 раза в день, вводить 30-40 мл (не меньше).

Данные о трудоспособности

Трудоспособность: неприменимо;

Листок нетрудоспособности: нет; По уходу: Нет

Сведения о лечащем враче и заведующем отделением

ФИО врача: Мисник Захар Андреевич; Врач-хирург;

ФИО заведующего отделением: Фомина Алёна Игоревна; Врач-терапевт;